IFAPME

FORMATION IFAPME · RENFORCEMENT MUSCULAIRE

# S'ENTRAÎNER À L'ÉLASTIQUE

Comprendre · Prouver · Programmer · Sécuriser

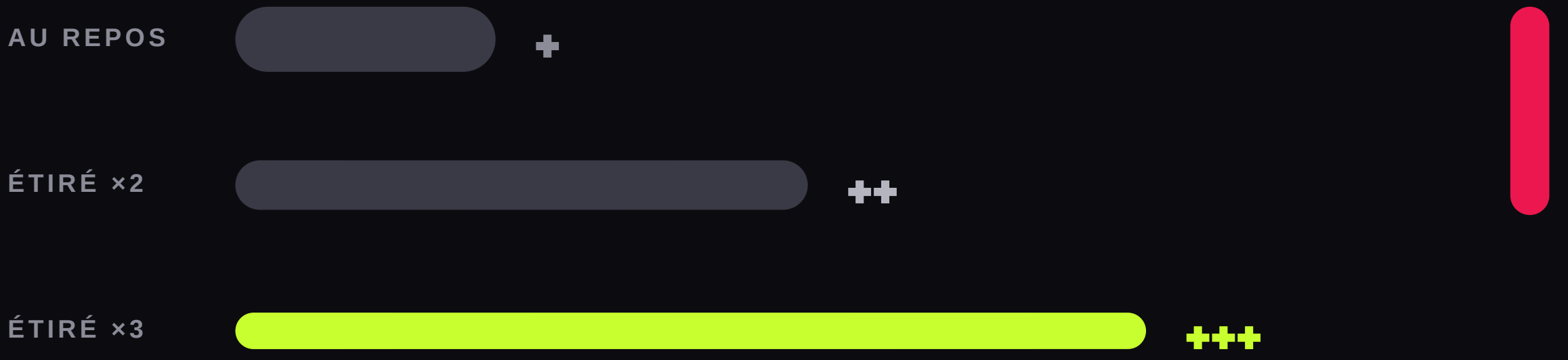
LA QUESTION DU JOUR

# UN SIMPLE ÉLASTIQUE PEUT-IL REMPLACER UNE MACHINE DE MUSCU ?

Réponse dans trois diapositives.

SOURCES réponse et références à la diapositive 5.

# PLUS ÇA S'ÉTIRE, PLUS ÇA RÉSISTE




Faible au départ, **maximale en fin de mouvement.**

Loi de Hooke · $F = k \cdot \Delta x$

SOURCES Simoneau et al., JOSPT 2001 ; McMaster, Cronin & McGuigan, Strength Cond J 2009.

# 4 OUTILS, 1 CODE COULEUR

## BANDE PLATE

Rééducation, seniors

## TUBE À POIGNÉES

Renfo général

## MINI-BAND

Hanches, fessiers

## POWER BAND

Sport, tractions

DU + LÉGER



AU + FORT

Jaune → Rouge → Vert → Bleu → Noir → Argent → Or (Thera-Band — varie selon la marque)

SOURCES Page & Ellenbecker, Human Kinetics 2003 ; Uchida et al., J Phys Ther Sci 2016 ; gamme Thera-Band.

# OUI.

## Mêmes gains de force qu'avec des machines ou des haltères.

- **Force équivalente** Lopes 2019
- **Activation musculaire comparable** Aboodarda 2016
- **Résultats = machines** Colado 2008
- **Efficace chez les seniors** Martins 2013

SOURCES Lopes et al., SAGE Open Med 2019 ; Aboodarda et al., Clin Biomech 2016 ; Colado & Triplett, JSCR 2008 ; Martins et al., Arch Gerontol Geriatr 2013.

# POUR TOUT LE MONDE

| | |
|---|---|
| **RÉÉDUCATION** | Reprise en douceur, avec le kiné |
| **SENIORS** | Force, équilibre, autonomie |
| **SPORTIFS** | Barre + élastique = plus de puissance |
| **ENTREPRISE & DOMICILE** | Peu de place, petit budget |

SOURCES Martins et al., 2013 ; Anderson, Sforzo & Sigg, JSCR 2008 ; Andersen et al., Phys Ther 2010 ; OMS 2020.

# LE POUR ET LE CONTRE

## +

- Léger, pas cher
- Toutes les directions
- Doux pour la reprise
- Pas d'élan, pas de triche

## −

- Pas de kilos affichés
- Faible en début de mouvement
- Limité pour les très forts
- S'use, peut casser · latex

SOURCES Page & Ellenbecker, 2003 ; McMaster et al., 2009 ; Lopes et al., 2019.

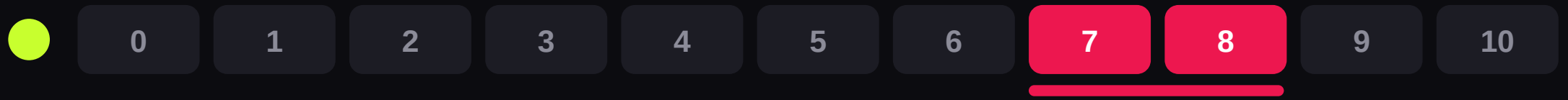
# LA RECETTE

**2-3** SÉANCES / SEMAINE

**8-12** RÉPÉTITIONS

**1-3** SÉRIES

**7-8** SUR 10 D'EFFORT




Échelle OMNI-RES : **finir la série « difficile », jamais à l'échec.**

SOURCES ACSM Position Stand, MSSE 2009 ; OMS 2020 (Bull et al., BJSM) ; Colado et al., JSCR 2012 (échelle OMNI-RES).

# 5 LEVIERS, DANS L'ORDRE

Série réussie 2 séances de suite ? → **levier suivant.**

## 1 TECHNIQUE

Amplitude contrôlée

## 2 VOLUME

+ reps, + séries

## 3 PRÉ-TENSION

Reculer de l'ancrage

## 4 RÉSISTANCE

Couleur au-dessus

## 5 TEMPO

Freiner le retour

SOURCES ACSM Position Stand, 2009 (surcharge progressive) ; Page & Ellenbecker, 2003.

IFAPME

# 6 EXERCICES, TOUT LE CORPS

01
## SQUAT
Jambes

02
## ROWING
Dos, posture

03
## DÉVELOPPÉ
Pectoraux

04
## PONT FESSIER
Fessiers

05
## ROTATION ÉP.
Épaules (coiffe)

06
## PALLOF PRESS
Gainage

SOURCES Andersen et al., Phys Ther 2010 ; Page & Ellenbecker, 2003 ; ACSM, 2009.

# AVANT, PENDANT, APRÈS

## AVANT

Inspecter la bande : entaille = poubelle

Allergie au latex ? Bande sans latex

## PENDANT

Ancrage solide, jamais à hauteur du visage

Max 2,5 × la longueur de repos

Ne jamais lâcher une bande tendue

## APRÈS

Ranger à l'abri du soleil et de la chaleur

SOURCES Page & Ellenbecker, 2003 ; Simoneau et al., 2001 ; recommandations du fabricant (Thera-Band).

À RETENIR

01 ÇA RÉSISTE QUAND ÇA S'ÉTIRE.

02 ÇA MARCHE AUTANT QUE LA FONTE.

03 ON DOSE AU RESSENTI : 7-8/10.

04 LA SÉCURITÉ D'ABORD.

RÉFÉRENCES


ACSM (2009) · Med Sci Sports Exerc 41(3)
Aboodarda et al. (2016) · Clin Biomech 39
Andersen et al. (2010) · Phys Ther 90(4)
Anderson et al. (2008) · J Strength Cond Res 22(2)
Bull et al. – OMS (2020) · Br J Sports Med 54
Colado & Triplett (2008) · JSCR 22(5)
Colado et al. (2012) · JSCR 26(11)
Lopes et al. (2019) · SAGE Open Med 7
Martins et al. (2013) · Arch Gerontol Geriatr 57(1)
McMaster et al. (2009) · Strength Cond J 31(1)
Page & Ellenbecker (2003) · Human Kinetics
Simoneau et al. (2001) · JOSPT 31(1)
Uchida et al. (2016) · J Phys Ther Sci 28(4)




SOURCES bibliographie complète dans les notes de cette diapositive.